جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ساميه على ابراهيم عبدالله
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الزيتون **العنوان :** ش طونباي
رقم البطاقة : 27302250101021 **رقم التليفون :** 01093764605 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 10-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 25-02-1973 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ساميه علي ابراهيم عبدالله
National ID: 27302250101021

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٧٣٠٢٢٥٠١٠١٠٢١ ٢٠٢١/٠١
محامى حر
أنثى مسلمة أرملة
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠١/١٠
١



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
ساميه
على ابراهيم عبدالله
٨ ش طوماتباى-ميدان ابن سندر
الزيتون - القاهره
٢٧٣٠٢٢٥٠١٠١٠٢١
IS5101003

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	: الأستاذه / ساميه على ابراهيم عبدالله	Request No.	: 13000435
Patient No.	: 27302250101021	Request Date	: 28/04/2022
Path No.	: SR-315/22	Verification Date	: 07/05/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 49 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data: Breast cancer and Uterine cancer

Nature of the specimen: Slides Revision
Gross Examination:
11 Blocks (3769) + 14 Slides

Microscopic examination:
* Mastectomy Slides:
• Histological type: Invasive Ductal Carcinoma
• Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): GII (3+2+1)
• Angioinvasion: Present
o Skin involvement: Tumour cells reaching base of nipple with free epidermis
• Additional Pathological Findings: Positive perineural invasion
• Biomarkers
Examination of ER stained slide show intense nuclear staining in 70% of the tumor cells.
Examination of PR stained slide show intense nuclear staining in 90% of the tumor cells.
Examination of HER2 stained slide show intense staining in >10% of tumor cells with complete membranous staining.
Examination of Ki67 stained slide show nuclear staining in 45% of tumor cells

* Total Hystrectomy with unilateral salpingectomy Slides:
Microscopic examonation showed Endometrium with Endometroid carcinoma (villoglandular type), infiltrating more than half of the myometrium, with vascular emboli. Free cervix, with chronic non-specific cecrvicitis and Nabothian cyst. Free tube with salpingitis and pyosalpinx.

Diagnosis:
Breast cancer and Uterine cancer, Slides Revision:

Verified by :
dr.menna atef

Room No. (4) - First Floor Building No. 957 - Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: سامیه علي ابراهيم عبدالله	
MR. : 5169	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

A case of breast cancer diagnosed in 2022, the patient has been on tamoxifen since December 2022 for a duration of three months.

A case of breast cancer diagnosed in 2022, the patient has been on fulvestrant (FEMARA) since December 2022 for a duration of three months.

The patient is currently receiving fulvestrant plus supportive therapy for three months. The last imaging in August 2025 showed a free CT chest and a stationary coarse lesion on ultrasound and mammogram.

تحريرا في ,

التاريخ :	20-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : nada mohamed elsayed

يعتمد ,

Patient Name	: الأستاذه / ساميه على ابراهيم عبدالله	Request No.	: 13000435
Patient No.	: 27302250101021	Request Date	: 28/04/2022
Path No.	: SR-315/22	Verification Date	: 07/05/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 49 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

* Mastectomy Slides:
- Invasive Ductal Carcinoma GII
- Tumour cells reaching base of nipple with free epidermis
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- HER-2: Positive (score 3+)
- Ki67: Positive in 45% of tumor cells.

* Total Hystrectomy with unilateral salpingectomy Slides:
- Endometroid carcinoma (villoglandular type), infiltrating more than half of the myometrium.
- Free cervix, with chronic non-specific cecrvicitis and Nabothian cyst.
- Free tube with salpingitis and pyosalpinx.

Prof. Lubna Omar
Dr. Menna Atef

Verified by :
dr.menna atef

Room No. (4) - First Floor Building No. (82) - Nile Corniche - Maadi El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

ا.د. أحمد كمال الكبرى
ا.د. محمد أبو الهدى درويش
ا.د. عمر حسين عمر
ا.د. وحيد حسين طنطاوى
ا.د. ياسر عبد العظيم عباس
ا.د. أحمد محمد منيب
أساتذه الأشعة التشخيصية
كلية الطب - جامعة عين شمس

مركز مصر للأشعة
MISR RADIOLOGY CENTER MRC

MRS.: SAMIA ALI IBRAHIM	ID: 1835476
DEAR SIR	DATE: 14/04/2022

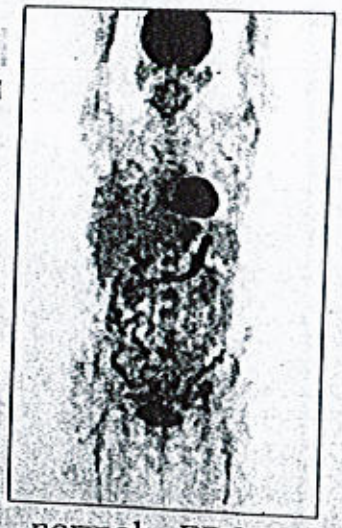
^{18}F-FDG PET/CT EXAMINATION

History:-

49-years old female patient, presented with history of right breast cancer (invasive ductal carcinoma grade-II), as well as endometrial cancer (endometrioid adenocarcinoma grade-II), for which right mastectomy and hysterectomy were done three weeks ago and referred for PET/CT assessment.

Procedure:-

- 9.5 mCi 18F-FDG was administrated to the patient and imaged after appropriate time.
- The blood glucose level was 150 mg/dl.
- A low dose non-contrast CT for attenuation correction and anatomic localization followed by PET images from the skull vault to the mid thigh were obtained.
- A diagnostic 128 MDCT non contrast examination was taken of the same regions. Images of CT and corresponding functional PET images are taken in axial, coronal and sagittal planes.



PET/CT FINDINGS:-

A] Head and Neck:-

- The neck is devoid of any abnormally hypermetabolic lymph nodes.
- The visualized portions of the brain exhibited normal FDG biodistribution.
- Physiological FDG uptake is seen in the oropharynx, salivary glands and larynx.
- No parenchymal thyroid focal lesions could be elicited.
- Mild bilateral maxillary sinusitis is noted.

B] Chest:-

- The right mastectomy operative bed shows mildly active subcutaneous fat stranding with small localized fluid collection (seroma), measuring about 10x22x34mm [reactive post operative changes], yet, no hypermetabolic soft tissue lesions detected that would account for residual neoplasia.



New Cairo Branch : Off 90 St., by MRC Square, Between Air Force Specialized Hospital and Lake View Compound
Heliopolis Branch (1) : 8 El Khalifa El Maamoun St., Heliopolis
Heliopolis Branch (2) : 11 El Merghany St., Lotfy & Zalat Building, Beside Heliopolis Club
19773
012 1114031
www.misrradiologycenter.com

PET Scan
18DGGTYBERE D SCANNER

ا.د. أحمد كماري
ا.د. محمد أبو الهدى
ا.د. عمر حسين
ا.د. وحيد حسين طنطاوي
ا.د. ياسر عبد العظيم عباس
ا.د. أحمد محمد منيب
أساتذة الأشعة التشخيصية
كلية الطب - جامعة عين شمس

- No hypermetabolic left breast soft tissue lesions detected.
- Mildly active left axillary lymph node is noted, measuring about 1.4cm and achieving up to 3.7 SUV max.
- No other metabolically active lymph nodes detected.



- No pulmonary nodules or pleural effusion seen.
- Inactive fibrotic bands at right lung upper and middle lobes are noted (likely post radiation sequalae).
- Normal tracer biodistribution uptake is noted in the myocardium.

C] Abdomen & Pelvis:-

- The pelvic operative bed is clear and devoid of any hypermetabolic soft tissue lesions that would account for residual neoplasia.
- Mildly active fat stranding is seen along the lower anterior abdominal wall surgical incision line is noted (reactive post operative inflammatory changes).



- There is normal distribution of the radiotracer within the gastrointestinal and genitourinary systems without focal areas of abnormal metabolism.
- Physiological uptake in liver, adrenal glands, spleen and pancreas.
- Physiological excretion of FDG in the kidneys.
- No ascites or hypermetabolic lymphadenopathy noted.

D] Musculoskeletal:-

- No metabolically active osseous lesions could be detected along the surveyed skeleton.

New Cairo Branch : Off 90 St., by MRC Square, Between Air Force Specialized Hospital and Lake View Compound
Heliopolis Branch (1) : 8 El Khalifa El Maamoun St., Heliopolis
Heliopolis Branch (2) : 11 El Merghany St., Lotfy & Zalat Building, Beside Heliopolis Club
19773
01211114881
www.misrradiologycenter.com

PET Scan
[DOCTYPE PET SCAN]

ا.د. أحمد كمال ار
أ.د. محمد أبو الهدى در
ا.د. عمر حسين عم
ا.د. وحيد حسين طنطاو
ا.د. ياسر عبد العظيم عباس
ا.د. أحمد محمد منيب
أساتذه الأشعة التشخيصية
كلية الطب - جامعة عين شمس

CONCLUSION:-

- **No evidence of hypermetabolic residual neoplasia at right mastectomy and pelvic operative beds, with expected mildly active postoperative changes, as foredescribed.**
- **Mildly active left axillary lymph node, that could be reactive or metastatic, for follow up.**
- **No otherwise active lesions detected elsewhere in the body.**

MUCH OBLIGED

A PROF MOSTAFA ABDELKAWY

PROF DR. OMAR HUSSEIN **A. PROF. DR. SUSAN ADIL**

New Cairo Branch : Off 90 St., by MRC Square, Between Air Force Specialized Hospital and Lake View Compound
Heliopolis Branch (1) : 8 El Khalifa El Maamoun St., Heliopolis
Heliopolis Branch (2) : 11 El Merghany St., Lotfy & Zalat Building, Beside Heliopolis Club
19773
www.misrradiologycenter.com

PET Scan
[[DOCTYPE PET_SCAN]]

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

البنت المصرية هي طيبة

MDT FORM

17/5/2022

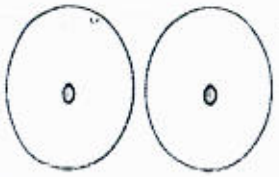
Name	سماسة على ابراهيم	MRN	٢٠٢٢١٦٧١٣
		ID	٢٧٢٠٢٢٥٠١٠١٠٢١
Age		Phone	٠١٠٠٩٢٧٦٤٦٠٥
Menopausal status		marital status	
OCP		Family history	
Co morbidity	DM on oral Diamicron.		

Clinical Data

Bx:

ER: 8/8	PR: 8/8	HER 2: +3	Ki67: 50-60%

R L



Sonomammography :

Mets Workup:

TNM

Recommendations:

3 yrs ago Rt breast Mass → Rt BCS + ALND → PORT → Tamoxifen 5 yrs.

2022 → Rt breast mass → Completion mastectomy. IDC GII pT3

→ ↑ endometrial Thickness → Total hysterectomy & Salpingectomy.

↳ endometrioid adeno Ca, GII, infiltrating > ½ of myometrium

FIGO IB, Free Cx & Free salpingeal lift

MDT OUTCOME & PLAN

4 AC ثم 12 Taxol weekly/Herceptin ثم PORT for breast and VPI for

adjuvant after chemo

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
17/5/22			

17/5/2022

S Ayoub

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Patient's Name:	**Samia Ali Ibrahim Abdallah**
Date:	**2026-08-23**
Referred by:	Prof.Dr. **no doctor**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

Left Digital soft tissue mammography with high resolution sonography revealed:

Clinical summary: Status post right MRM & ALAND, for two years, routine follow up.

Findings:

Left breast.

- Moderate dense breast tissue . (ACR C)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- **One indeterminate nature left axillary LN that measures (20 x 18 mm) with thick cortex of 6 mm .**

Right mastectomy bed.

- Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections..
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.

Conclusion:-

- ***Left breast (BIRADS 3): One indetrminate nature left axillary LN for follow up.***
- ***Clear right mastectomy bed and axilla.***

Recommendation:-

- ***For annual follow up.***

Prof .MONA ZAKY